

1장. 골반저 해부 및 배뇨생리

- 이 단원은 기출도 적고 설명도 간단히 하고 넘어가셨습니다.

1. 항문거근

정의	- 골반기저층의 근육을 지칭하는 광범위하고 일반적인 명칭
종류	- 장골미골근 부위, (더 중요한) 치골내장근 부위로 구성 • 장골미골근 : 얇은 근육층 (항문거근의 뒤쪽판) • 치골내장근 : 치골에서 시작, 질과 직장의 측벽에 붙음 └ 수축 시 직장, 질, 요도를 전방으로 당겨 내강을 수축시킴
역할	- 골반장기를 하방으로 미는 복강내압을 상쇄하는 역할 - 골반지지 역할 - 골반인대의 과도한 이완을 방지하고 지탱하

2. 골반인대

정의	- 윤문상 조직, 혈관 및 근섬유가 느슨하게 응축된 것
종류	- 원인대, 누두 골반인대, 기인대 등
역할	- 자궁이나 질과 같이 지지받는 장기를 자리에 위치하게 하는 닻으로의 기능 (그 자체의 지지기능은 거의 없음) - 정상적인 근육이 소실되면 비뇨생식공의 처짐, 확장이 일어나서 골반장기 탈출을 유발함

3. 결합조직

역할	- 장기의 구조적 통합성을 유지하도록 돕는 주머니 형성 - 근육과 힘줄을 덮어 신체 타구조물과 붙는 근막 형성
특징	- 스트레스에 반응, 지속적 교체와 개형을 하는 동적 조직
질환	(1) 스트레스 요실금 : 근막에 교원질 양과 강도 저하 (2) 생식기/직장 탈출 : 관절 과잉운동성과 관련

4. 하부요로의 기능

1) 정상적인 요도 폐쇄(외/내인의 조화를 이름으로 유지)

외인성 인자 (요도 주변)	- 항문거근, 골반 내 근막, 골반측벽과 요도와의 부착 - 요도 밑에서 복강내압 증가에 대해 긴장상태로 유지	
	문제	- 정상 지지력 소실, 요도와 방광경부의 과잉운동성 - 스트레스 요실금의 원인이 됨
내인성 인자 (요도 자체)	- 요도벽 골격근, 정맥하 정맥총, 요도벽 평활근, 요도 내막 주름, 요도 탄성, 교감신경계에 의한 긴장도 등	
	- 선천성 발생학적 결함, 외상, 외과적 처치나 수술, 호르몬, 신경학 적 손상 등에 영향 받아 문제발생	

2) 방광 및 요도

① 방광

- 소변저장, 수의적 조절 하에 소변 배출하는 평활근으로 이루어진 주머니
- 방광이 충만되는 동안 불수의적인 수축 없이 비활동적으로 유지되어야 함

② 여성 요도

- 성인 여성 요도 길이 4cm, 직경 0.6~0.8cm. 원위부에 요도주위선 분포
- 요도 기능은 방광과 반대
 └ 요저장 : 방광 이완 & 요도 수축 / 요배출 : 방광 수축 & 요도 이완

3) 신경지배

- 하부요로는 3가지 원천으로부터 신경지배

└ 자율신경계의 교감/부교감분지, 외요도괄약근의 체신경계의 신경원

자율신경계	교감분지	방광의 저장을 일차적으로 조절 (긴장 시 활성화)
	부교감분지	방광의 배출을 일차적으로 조절 (이완 시 활성화)

4) 배뇨

- ① 배뇨역치: 반사적인 방광근의 수축이 일어나는 방광용적 (말초신경계에 의해 촉발)
- ② 성인 1일 소변량: 1000~1500cc
 └ 여성은 1200cc 정도, 1회 배뇨량: 300cc 정도이며, 하루에 5~8회 정도 배뇨
- ③ 배뇨주기 : 충만기 - 저장기 - 배설기
- ④ 배뇨감각 인식 : 방광내 요량 150cc일 때 처음, 400cc일 때 급박감

제 2장 과민성 방광

1. 개술

1) 정의 및 역학

- 불수의적인 소변배출
- 역학 : 중년이후 여성에서 발생 수 높음, 65세 이상의 여성의 15~30%
- 특징 : 생명유지에는 직접적 영향 X → 삶의 질과 밀접한 관련 → 임상적 중요성 높음
- 한의학 :
 - 知而不能固한 상태 (인지는 하지만 참지 못함)
 - 遺溺, 失瘕, 小便失禁, 尿床候 등의 범주
 - 원인을 心腎不交, 肺氣虛, 熱, 脾肺氣虛, 肝腎虧損 등으로 보았고, 골반저의 이완을 말하는 陰挺과 요실금이 흔히 동반됨을 인지

2. 요실금의 종류

1) 스트레스 요실금(복압성 요실금)

정의	- 골반지지조직의 결손·이완이나 방광경부 기능부전으로 복압 상승할 때 배뇨 저지하는 압력이 견디지 못해 불수의적으로 배뇨하는 것
역학	- 60대 이하 여성 요실금의 가장 흔한 유형
원인	- 골반지지조직의 약화(직접적원인), 만성적 기침, 만성적 요로감염 등
동반증상	- 자궁탈출, 방광낭류

2) 절박요실금

정의	- 갑작스럽고 강한 배뇨감과 연관된 불수의적 소변 유출로, 억제 불가 정의한 방광근육 수축이나 배뇨반사 억제불가로 발생
역학	- 노인여성에서 가장 흔한 유형
원인	- 방광 배뇨근 과활동 - 신경학적 질병에 의해 가능, 방광배뇨근 불안정, 방광염 심할 경우
동반증상	- 생각하지 못한 많은 양의 소변유실이나뇨의가 급박한 요실금을 갑자기 경험하게 됨

3) 혼합요실금과 일과성 요실금

혼합요실금	- 스트레스 요실금과 절박 요실금이 같이 있는 경우
기능적·일과성 요실금	- 스트레스 요실금이나 배뇨근 과활동이 원인인 요실금 이외에 다양한 상태의 불수의적인 소변유실 - 가역적인 요실금을 일으키는 원인 : 섬망, 감염, 위축성 요도염과 질염, 약물 복용, 정신적 요인, 운동제한, 대변 매복 및 지나친 소변 생성 등

3. 진단

① 요실금의 병기

Grade I	기침, 재채기 등 복압이 상승될 때 일과성 소변누출
Grade II	약간의 힘을 기울이는 동작에서 요실금 발생
Grade III	아주 작은 동작에도 계속해서 소변누출 발생. 내인성 괄약근의 손상

② 검사

- 신체검사 : 요실금 재현, Bonney test, Q-tip test
- 기타검사 : 요도경검사, 방광경검사, 방광내압측정, 요역동학 검사
- > 요역동학 검사는 3단계에 필수적임

③ 감별진단 : 요의급박증

4. 치료

1) 비수술적 요법

- 우선적으로 비침습적이고 안전한 치료법을 선택
- 증상 심하지 않거나 수술 원하지 않거나 임신 원하는 경우 비수술적 요법이 1차적 치료법으로 고려

2) 골반저부 근육운동

- 목적 : 치골미골근 강화시켜 복압 상승으로 절박감을 느껴도 스스로 강한 골반 수축이 일어나 억제하게 함
- 배뇨일지 → 배뇨간격을 늘려 정상 배뇨습관 가짐
- 케겔 운동 : 대표적인 골반저부 근육운동

3) 생체 되먹이기 요법

- 골반저근육 수축력과 수축방식을 근전도로 측정·피드백하면서 근력과 조절력

강화

4) 방광훈련

- 방광과 괄약근 조절을 다시 습득하게 하는 행동요법
- 목표 : 3시간에 한번씩까지 간격 늘리는 것

5) 생활습관 개선

- 음식섭취제한
 - └ 카페인, 산도 높은 음식, 향신료, 포도, 오렌지, 감귤, 초콜릿, 알코올 제한
- 과다한 수분섭취나 수분섭취의 제한도 요실금 유

6) 전기자극치료

- 항문거근을 전기적으로 자극하는 골반근육 재활치료.
- 외요도괄약근과 골반근육수축 유발시키고, 배뇨근의 반사 방해를 유발하여 방광의 수축 억제

7) 체외 자기장 치료

- 강한 자기장을 가해 형성된 와전류로 인체 근육과 신경을 전극 없이 자극하고 수축 시켜 근육 강화

8) 약물치료

- 가장 좋은 치료법은 행동치료와 약물치료 병행
- 호르몬제나 아세틸콜린 수용체 차단약물을 사용

9) 외과적 치료법

- 스트레스요실금에서 약물치료보다 더 좋은 효과를 보임
- 절박요실금 환자는 수술치료보다 약물치료 우선 시행
- 내인성 괄약근의 박약, 결핍은 드물고 치료 어렵다

5. 예후

- 외인성 인자에 대한 스트레스 요실금: 예후 좋음
- 내인성 인자에 의한 요실금: 예후 좋지 않음
- Grade3 : 내인성 괄약근 손상인 경우 많고, 예후 나쁨
- 수술 : 약 50% 완치, 약 20% 호전 약 20% 실패

6. 요실금의 한방치료

신기허한	배뇨가 잦고 소변이 맑으며 양이 많음, 얼굴창백	
	온신고삼	상표초산 기제한 공제한
폐비기허	배뇨가 잦고 해천, 신기핍력, 식욕부진, 변당	
	온보폐비 익기건운	보중익기탕 보원전
간신음허	소변량 적고 개운하지 않으며 색이 노랗다, 어지럽고 이명 있음	
	자보간신 좌이고삼	대보음환
방광축열	노단삼색황, 요도 작열감과 자통, 구고구건	
	청리습열	팔정산

제 4장 요로계 감염

1. 개술

1) 정의

- 요로감염은 인체의 각 기관 중 감염의 빈도가 높은 질환의 하나
- 콩팥, 요관, 방광, 요도와 전립샘 등 요로계에 미생물

2) 종류

- 급성 방광염, 만성 방광염, 요도염, 간질성 방광염과 요도증후군

※ 만성 방광염

- 1년에 3회 이상의 방광염이거나 지속적인 방광염 감염 상태

[위험인자] 성관계, 폐경기 후 에스트로겐 결핍, 요로계의 결석 ...

[예방법] 다량의 수분섭취, 2시간 간격의 배뇨, 성관계 중 윤활제 사용, 거품목욕이나 방취제 사용 피하기

[양방] 필요 시 성관계 후 1종의 예방적 항생제 복용 폐경여성의 경우 항생제 예방요법 + 호르몬요법 + 국소적 에스트로겐 크림

3) 치료

급성감염	방광습열	팔정산
	간경습열	용담사간탕
	습열하주	삼인탕
만성감염	간신음허	청생신기환
	기허불고	보중익기탕

제 5장 음정과 골반장기 탈출

1절 음정과 골반장기탈출의 개요

1. 개술

- ① 정의 : 자궁이 정상위치보다 낮게 내려와 질 아래로 내려온 상태
 └ 자궁탈출증에 해당
- ② 원인 : 만성적인 복압상승, 내인성 약화에 의한 정상 지지조직의 소실
- ③ 주요병기 : 기허하함, 신허불고, 포락손상(胞絡損傷), 포궁실삽(胞宮失攝)
 └ 분만 중 손상에 의해서도 발생

2. 진단과 감별진단

- ① 병력 : 분만 시 손상, 지연분만, 산후 너무 이른 시기에 힘든 일, 산후조리 부적절
- ② 증상 : 음부가 빠지는 듯한 느낌, 陰道로부터 무언가 탈출되어 달려있는 느낌
 심하면 노출된 조직 건조, 비대, 염증, 궤양, 출혈, 악취 등이 발생
- ③ 정도에 따른 분류

1도 탈출	자궁이 자궁 입구 밖으로 나오지 않은 모든 단계
2도 탈출	자궁경부만 질 입구 밖으로 나와 있는 단계
3도 탈출	자궁전체가 질 입구 밖으로 나와 있는 단계

3. 변증치료

기허하함	과로 후 가중, 머리가 어지럽거나 눈앞 어른거림 동반	
	익기승제	보중익기탕 회양승함탕
신허불고	요배부가 시리면서 아프고 머리가 어지럽고 눈앞 아른거림	
	익기보신	거원전 합 팔미지황환 내보환
습열하주	외음부 피부 홍종동통, 심하면 궤양, 냄새나는 황색 삼출액	
	청열리습	용담사간탕 합 오미소독음
분만손상	난산 혹 분만 중 손상이 있는 후 자궁하함	
	익기양혈 좌이승제	팔진탕가감

※ 보중익기탕가감 for 기허하함 음정

- 황기 15~30 만삼 12 백출 7.5 당귀 5 자감초 진피 승마 6.5 생강 대조

2절 음취**1. 개술**

- ① 정의 : 질에서 간혹 기체가 빠져나와 방귀 같은 소리가 나는 것
- ② 원인 : 골반저의 이완, 트리코모나스 질염, 신경정신성 인자
 └ 요실금, 골반부 불편감, 질 부위 둔중감, 요통, 성기능장애 동반

2. 변증시치

기허하함	미약한 음취의 소리가 간헐적으로 들리며 심신의 피로, 숨참
	보중익기탕
위조	방귀와 같은 음취의 소리가 들리며 복창, 통증, 대변 굳음
	옥녀전 합 지실도체환
기울	음취의 소리가 심하거나 가벼우며, 정신적 억압과 긴장 현저
	소요산
담습	음취의 소리가 질에서 들리고 묽은 백채하 증가, 홍협부 그득답답
	굴반계령지강탕

[제 9단원 여성의 미용과 일반 건강 관련 병증]**제 1장 피부와 부속기의 구조**

넘어가셨습니다, 9단원은 기출이 없습니다.

제 2장 여드름**1. 개술**

- 여성의 미용과 관련한 가장 대표적 피부질환
- 여성의 여드름은 여드름의 발현 및 정도변화가 월경주기에 영향을 받는 경우
 └ 다낭성난소증후군, 월경전증후군의 한 증상으로도 나타나기도 함
- 보통 12~14세에 시작하여 20대 중반에 쇠퇴하지만 20대/30대에 시작하여 수년 간 지속하기도 함
- 원인
 - 혈중 호르몬 농도의 변동과 관련
 - 일반적으로 배란중이거나 월경 전 악화 또는 재발
 └ P에 의해 피지분비가 증가하고, 동시에 모피지선의 개구부 크기가 좁아짐

***치료**

- 아직까지 완벽하고 효과적인 단일 여드름 치료법은 없다
 - 여성의 월경주기에 따른 변화와 수반증상을 고려하여 월경전 5~7일전부터 월경기간동안의 치료법 적용에 유의함
- 폐위온열 : 비파청폐탕
 비허담습 : 육군자탕
 기혈울체 : 도홍사물탕가감
 충임부조 : 소요산
 담어결취 : 이진탕 가감

제 3장 간반(肝斑)과 피부미백

1. 개술

- 연한 갈색이나 암갈색을 띠는 다양한 크기의 색소침착반이 뺨, 이마 등과 같은 햇빛 에 노출 되는 부위에 생기는 과색소 침착 질환
- 대부분 가임기 여성에서 호발, 임신 중 여성이나 간질환 환자에서 많이 나타남

2. 변증치료

- 간율기체 : 시호소간산가감
- 비허 : 향사육군자탕가감
- 충임부조 : 육미지황탕 합 이지환 가감

제 4장 한의학을 이용한 안면부 항노화 시술

- 피부 노화방지와 피부 주름개선 등 피부 항노화 시술과 관련한 다양한 침범이 임 상에서 많이 시술되고 있음
- 비수술적 방법이라는 안정성 + 전신 건강 개선의 효과

1. 안면미용침

정안침	- 한의학의 경락이론과 근막이완치료법을 바탕으로 안면부 주름 개선 및 피부질환을 치료 - 근막의 이완을 유발하고 근막조직 사이로 혈액, 림프 순환을 원활히 하여 안면 주름을 개선하고 피부 탄력 증가시키는 침시술
미소안면침	- 주름개선, 안면리프팅, 림프순환 개선 등을 목적으로 개발된 침술 - 안면 피부 속 표정근 주위의 경혈에 자침하여 근육 긴장성 수축과 이완 상태를 개선
미세다룬침 (MTS)	- 진피층에 손상을 줘서 회복되는 과정에서 피부의 회복을 촉진 - 잔주름은 피부자체 탄력 개선이 필요한데, 이것에 MTS가 좋음
매선	- 피부, 경락, 경근 등에 선을 매입하여 오랜 유침으로 인한 지속적인 자극을 통해 치료효과를 증대시키는 것 - 침과 영결된 봉합사를 진피하부, 피하지방층, 근막 등 특수 피부 결합조직층에 자입하여 피부 재생을 촉진 → 주름개선, 탄력증진

제 5장 냉증

1) 개술

- 냉각과민증이라고도 하며, 신체의 다른 부위는 냉감을 느끼지 않는 실온임에도 불구하고 신체의 특정 부위만 차가움을 느끼는 경우
- 병인병기 : 인체 특정부위의 혈액순환이 불충분해지면 그 부분의 체온이 하강하게 되어 냉증을 호소하게 됨

2) 변증

비양허	부자이중탕	혈허	당귀작약산
신양허	우귀환	기허	보중익기탕
어혈	도홍사물탕	수독	영계출감탕